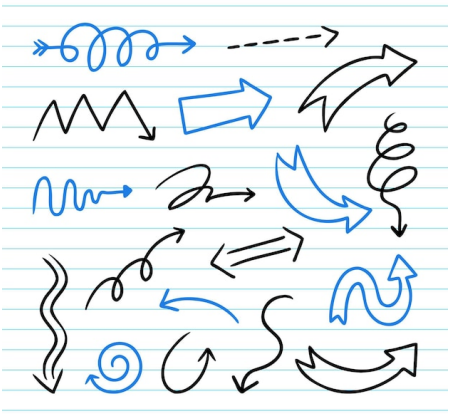


TEMA 50



ESQUEMA DEL TEMA

LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS ADICCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DE MADRID SALUD.

INTRODUCCIÓN

Evolución atención a las Drogodependencias.

1.- Primeras actuaciones: 1.987, primer CAD en Puente de Vallecas. Red centrada en la heroína.

2.- Creación de la Comisión Antidroga: 1.987 /Administración Municipal para diagnóstico de las drogodependencias. 1.992 / Incorporación ONGs.

3.- Aprobación Plan Municipal contra las Drogas. 1.988 / Aprobación PMD → diseño de programas de prevención, diversificación de los recursos de asistencia y reinserción …

4.- Quinquenio 1.991-1.995. Enriquecimiento de la red con nuevos dispositivos: Comunidad Terapéutica, Pisos de Apoyo, Talleres de Inserción, Centros Reducción de Daños …

5.- Quinquenio 1.996-2.000. 1.997 / Implementación programas de metadona (Convenio con Cruz Roja).

6.- Trienio 2.001-2.003. Consolidación de la red (7 CADs y 5 Centros de Metadona), educación para la salud, prevención …

7.- Cuatrienio 2.004-2.007. 2.004 / Creación del Organismo Autónomo "Madrid Salud" → El **Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid** asume las actuaciones en materia de **drogodependencias y otros trastornos adictivos.**

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

Ámbito europeo.	**Ámbito nacional.**	**Ámbito autonómico.**
. Tratado Constitutivo de la CE. . Estrategia Europea de lucha contra la droga.	. Constitución Española (art. 43). . Ley General de Sanidad, Ley 14/1.986. . Estrategia Nacional sobre Drogas, 2.017-2.024.	. Ley 5/2.002 sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

1.- LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS ADICCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD: Políticas municipales en salud pública y drogodependencias y otros trastornos adictivos.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADICCIONES: Departamento de Prevención, de Asistencia y de Reinserción.

1.1.- RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MADRID.

Complejidad de la realidad de las adicciones → Abordaje integral → **Trabajo en red ("red de atención pública y diversificada -Ley 5/2.002-).**

- Coordinación de la red de adicciones con ASP, Salud Mental, Educación …
- Creación de espacios permanentes de trabajo.

NIVELES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS.	
Nivel 1. **Atención en proximidad.**	. Detección y captación de personas con adicciones que no acceden a tratamiento ambulatorio → orientación, información y atención social y/o sanitaria. . Perspectiva de reducción de daños. Contexto de proximidad. . Motivación para el tratamiento y establecimiento de vínculo terapéutico → Derivación al segundo nivel. • Centro de Atención Básica Sociosanitaria. • Unidad Móvil Reducción del Daño El Madroño. • Intervención con población inmigrante Istmo. • Programa de Mediación Comunitaria.
Nivel 2. **Centros ambulatorios.**	CADs y CCADs. Centros socio-sanitarios con equipos interdisciplinares → Atención personal individualizada y/o grupal en régimen ambulatorio a personas con riesgo o con trastornos de adicciones. . Eje de la intervención integral y centros de referencia de la red. . Diseño y coordinación de planes de intervención individualizados. . Derivación a recursos de nivel 3: temporales o parciales. . Coordinación con los recursos de nivel 1. • **7 CADs (Centros de Atención a las Adicciones).** • **3 CCAD (Centros Concertados de Atención a las Adicciones).** **NOTA:** la Comunidad de Madrid tiene su propia red asistencial, los **CAIDs, Centros de Atención Integral a las Adicciones.**
Nivel 3. **Recursos específicos.**	. Acceso desde el nivel 2 (CAD y CCAD) → consecución de objetivos concretos o por áreas de intervención. . Atención específica por tiempo limitado. • Unidad de desintoxicación hospitalaria, Centro de Patología Dual, Comunidad Terapéutica, Recursos convivenciales, SAJIAD …

DISPOSITIVOS DE PRIMER NIVEL

UNIDAD MÓVIL MUNICIPAL DE REDUCCIÓN DEL DAÑO "MADROÑO".

Ofrece a personas drogodependientes en exclusión social, atención básica → Prevención de enfermedades y daños y riesgos → Captación y derivación a otros recursos.

- Detección / Captación a personas con dificultades de acceso a la red / información sobre programas y recursos / motivación / atención sanitaria básica / reducción de daños y de riesgos / servicios básicos (alimentación, ropa, higiene) / acceso a otras prestaciones y recursos.
- Metadona / atención sanitaria básica / información y control de enfermedades / educación para la salud / información y asesoramiento sobre recursos sociales / acompañamiento y apoyo / intercambio de jeringuillas y preservativos / alimentación y vestuario / atención psiquiátrica de bajo umbral.

CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES.

Asistencia y atención socio-sanitaria básica a población adicta alejada a los recursos normalizados → Reducción de daños.

- Acercamiento a la red integral a través de programas de intervención adaptados / prevención de consecuencias negativas del consumo / Información y orientación / Apoyo al ingreso en dispositivos asistenciales / Mejora de la utilización de recursos.
- Alimentación básica, intercambio de jeringuillas y otros materiales de consumo, educación sanitaria individualizada, vacunación, detección precoz de patologías, cuidados sanitarios básicos, información sobre recursos, acompañamientos y apoyos, gestión de acceso a centros …

SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN INMIGRANTE "ISTMO".

Oferta de servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social para población inmigrante / Mediación para facilitar la adaptación a la oferta terapéutica.

- Conocimiento de las características y necesidades de la población inmigrante / captación del colectivo / oferta de tratamientos adaptados / coordinación con recursos de apoyo y de reinserción / propuesta de nuevos recursos.
- Acompañamiento individualizado y seguimiento de casos / información y ayuda en documentos / apoyo lingüístico / mediación con recursos de la red / asesoramiento y apoyo a profesionales.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.

Disminución de la conflictividad por la apertura de centros o la presencia de drogodependientes en zonas concretas (apoyo a la integración social / disminución del rechazo).

- Conocer necesidades de integración socio-comunitaria / Disminución de la conflictividad mediante mediación comunitaria, reducción de presencia, acceso a recursos …
- Contacto y mediación con el tejido asociativo / educación de calle / intervenciones individuales, coordinación, programación de actividades …

DISPOSITIVOS DE TERCER NIVEL.

Unidad Hospitalaria de Desintoxicación de alcohol.

Desintoxicación hospitalaria y estabilización de pacientes con dependencia alcohólica.

- Atención individual, psicológica y psiquiátrica. Psicoterapia grupal, educación para la salud, autocontrol de la ansiedad …
- Tiempo de estancia 14 días.

Centros de Día.

Cobertura de necesidades básicas de relación, alimentación, abrigo, higiene, expectativas de mejora … a población con deterioro socio-sanitario importante.

- Centro de Día de Casa de Campo y de Cáritas

Recurso convivencial terapéutico para jóvenes y adolescentes menores de 25 años.

Espacio físico de convivencia para población menor de 25 años sin soporte familiar o social → estabilización, adherencia al tratamiento e incorporación social.

- Desintoxicación, deshabituación, adquisición de hábitos higiénicos y autocuidados.

Comunidades Terapéuticas: CT para pacientes con patología dual y CT para pacientes crónicos y/o con deterioro cognitivo.

Tratamiento en régimen de internado para población adicta sin soporte familiar o social para realizar tratamiento ambulatorio → desintoxicación, deshabituación y adquisición de pautas de conducta adecuadas.

- Atención individual, psicológica y psiquiátrica, psicoterapia grupal, intervención socioeducativa, talleres formativos y de ocio …
- Posteriormente se reincorporan a los recursos ambulatorios.
- Tiempo de estancia: 6 meses.

- CT para pacientes con patología dual: abuso drogas + trastorno mental.
- CT para pacientes crónicos o con deterioro cognitivo.

UNIDAD HOSPITALARIA DE PATOLOGÍA DUAL.

Valoración, tratamiento y estabilización de patologías psiquiátricas asociadas a las adicciones en régimen hospitalario.

- Tiempo de estancia: 3 semanas – 3 meses.

CENTRO DE DÍA DE PATOLOGÍA DUAL.

Valoración, tratamiento y estabilización de patologías psiquiátricas asociadas a las adicciones en régimen de Hospital de Día.

- Tiempo de estancia: 3 semanas – 3 meses.

RECURSOS CONVIVENCIALES DE APOYO AL TRATAMIENTO Y A LA REINSERCIÓN.

Proporcionar a la población adicta sin soporte familiar o social un espacio físico de convivencia, que favorezca la estabilización, la adhesión al tratamiento y el proceso de rehabilitación y reinserción social, mediante apoyo psico-social en coordinación con los CAD.

• **Pisos de Apoyo al Tratamiento (PAT).** Recursos convivenciales en territorio urbano para personas en tratamiento en CAD/CCAD. 4 pisos por perfiles (PSH, menores de 25 años, personas con deterioro y/o patología dual y personas en tratamiento). • **Pisos de Apoyo a la Reinserción.** Recursos convivenciales y socioeducativos en entorno urbano → Vida independiente, autónoma y socialmente normalizada. 3 pisos de reinserción: Nivel básico (9 meses), de Patología Dual (9 meses) y de autogestión (6 meses).
UNIDAD DE FARMACIA.
Adquisición, preparación, custodia y distribución oral de la metadona, aproximando su dispensación al lugar de residencia o trabajo, ampliando los horarios de dispensación.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL (SOL).
Servicio de orientación y asesoramiento en formación, capacitación laboral y empleo → Integración laboral estable y de calidad / Implicación de organismos de gestión de empleo y del ámbito empresarial.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES.
Servicio de orientación y asesoramiento en formación, capacitación laboral y empleo → Integración laboral estable y de calidad / Implicación de organismos de gestión de empleo y del ámbito empresarial para adolescentes y jóvenes.
TALLERES PRELABORALES DE CAPACITACIÓN.
Formación y capacitación profesional → Mejora de los niveles de empleabilidad y apoyo a la adecuada inserción laboral.
TALLERES PRELABORALES DE CAPACITACIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES.
Formación y capacitación profesional para adolescentes y jóvenes → Mejora de los niveles de empleabilidad y apoyo a la adecuada inserción laboral.
SERVICIO DE ATENCIÓN A JUECES E INFORMACIÓN AL DETENIDO (SAJIAD).
Favorecer la plena integración social de personas con adicciones con problemas judiciales / Favorecer la plena integración social de jóvenes en riesgo o con problemas de adicción y problemas judiciales.
PROGRAMA DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.
Promoción y fomento de la colaboración de la iniciativa social → Subvenciones.

ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGODEPENDENCIAS.

2.012. Protocolo de intervención desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Drogodependencias (Centros de Atención a las Adicciones).

1.- PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL. PAPEL DEL TS.

1.- Atención a la demanda inicial.	Demanda de usuario / familia por vía telefónica / presencial → • Recepción (personal administrativo: escucha de la demanda, toma de datos iniciales y primera cita). • Acogida (primera cita con técnico: escucha activa, información mínima, prioridades de atención …). Utilización de la entrevista motivacional breve.
2.- Valoración interdisciplinar.	Valoración aspectos biopsicosociales → 7 dimensiones: salud y autocuidados, psicopatología, consumo, familiar, socio-relacional, formativo-laboral y ocio (áreas sanitaria, psicológica, social y ocupacional) → Sistema de Evaluación Multidimensional o Sistema de evaluación objetiva de resultados del tratamiento. • El TS utiliza la historia social. • Elaboración de primera hipótesis de trabajo.
3.- Evaluación multidimensional y diseño del Programa Personalizado de Intervención.	Evaluación multidimensional (salud, psicopatología, consumo, familia, relaciones sociales, formación y empleo, ocio y tiempo libre) → Diseño del PPI: - Objetivos. - Actividades. - Recursos necesarios. Debe ser consensuado con el paciente y/ o familia. Identificación de los objetivos por áreas, Selección de las estrategias terapéuticas más adecuadas, Puesta en marcha de actuaciones y utilización de los recursos y herramientas terapéuticas necesarias.
4.- Desarrollo del PPI.	Desarrollo del PPI (diseñado y consensuado), seguimiento y evaluación continua (para introducir las modificaciones que sean necesarias). • Graduación de la intervención del TS (en función de los factores de riesgo de exclusión social). Se trabaja y se valora en relación a 7 ejes: • **Eje 1: salud / autocuidados.** Reducir y controlar los riesgos y daños asociados y/o producidos por el consumo de drogas / Conseguir hábitos saludables. • **Eje 2: psicopatología.** Lograr la mayor estabilidad psíquica del paciente. • **Eje 3: consumo.** Lograr la abstinencia, la máxima reducción del consumo o el consumo de menor riesgo. • **Eje 4: familia.** Conseguir y mantener unas relaciones familiares adecuadas y satisfactorias. • **Eje 5: socio-relacional.** Conseguir y mantener unas relaciones sociales saludables.

	• **Eje 6: formativo-laboral.** Conseguir y mantener una formación y/o trabajo adecuado, satisfactorio y estable. • **Eje 7: ocio**. Organización productiva del tiempo libre y disfrute de ocio saludable. **La intervención se desarrolla en diferentes niveles:** • **Nivel individual.** Con el paciente y/o familia a través de la entrevista. • **Nivel grupal.** Grupos de acogida, de inicio, de prevención de recaídas, de educación para la salud … • **Intervención familiar.** A través de entrevistas. Con familias de pacientes o con familias "solas". Intervención individual y grupal.
5.- Coordinación.	Coordinaciones internas (con el resto del equipo) y externas (recursos de la red o recursos comunitarios).
6.- Evaluación de resultados.	Evaluación continuada a través de indicadores que permiten la medición objetiva de los cambios en las diferentes dimensiones de la intervención.

2.- INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES.

. Motivación y apoyo para el mantenimiento o incorporación a actividades.

. Promoción de hábitos y estilos de vida saludables, ocio, relaciones sociales …

. Apoyo en los vínculos socio-familiares.

. Acompañamiento social y trabajo en red (perspectiva de género y de multiculturalidad).

. Orientación para la utilización adecuada de recursos.

. Motivación y apoyo para la realización de gestiones sobre documentación básica y tramitación de prestaciones y recursos.

. Motivación y apoyo para atención de proximidad, educación de calle, acompañamientos …

Especificidades de la atención en función de los colectivos.

Adolescentes y jóvenes.	Menores de 24 años.
Mujeres vulnerables.	Abuso/dependencia y otras situaciones de riesgo.
Pacientes con bajo potencial de cambio.	Edad avanzada, largas historias de consumo, tratamientos prolongados sin cambios …
Pacientes con patología dual.	Abuso/dependencia y/o trastorno mental.
Sin hogar.	Abuso/dependencia y sinhogarismo.
Necesidades especiales por origen, cultura …	Dificultades idiomáticas y/o culturales que constituyen barreras añadidas.
Conflictos legales o judiciales.	Problemas judiciales por delitos relacionados con la dependencia a las drogas.

3.- INTERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD.

La (re)construcción del vínculo social implica la mirada a la comunidad.

. Atención a jóvenes y docentes de recursos educativos para visibilizar la labor de los CAD y sensibilizar sobre los riesgos asociados.

. Participación en CAFs y ETMFs (y otras plataformas conjuntas).

. Promoción y planificación de actuaciones grupales con otros recursos (CMSc, Agentes de Igualdad, SS.SS.).

. Trabajo en red con el tejido asociativo.

. Valoración conjunta de casos para abordaje comunitario.